

# **Vigilância Sanitária, Epidemiológica e Ambiental**

Bárbara Trindade

Aula 01

Vigilância em  
Saúde





Diretor Executivo  
DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Diretora Editorial  
ANDRÉA CÉSAR PEDROSA

Projeto Gráfico  
MANUELA CÉSAR ARRUDA

Autor  
ANALICE OLIVEIRA FRAGOSO

Desenvolvedor  
CAIO BENTO GOMES DOS SANTOS

# **Autora**

**BÁRBARA TRINDADE**

Olá, meu nome é Bárbara Trindade. Sou formada em Ciências Biológicas/ Ciências Ambientais pela Universidade Federal de Pernambuco, por onde também me tornei mestre em Engenharia Civil, na área de concentração de Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos. Sou especialista em Vigilância em Saúde Ambiental pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e, é no âmbito da Vigilância Ambiental que desenvolvi boa parte de minha experiência técnico-profissional. Atuei no Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Milton Bezerra Sobral por mais de cinco anos, realizando o monitoramento da água destinada ao consumo humano do Estado de Pernambuco, dentro das ações estratégicas do Vigiágua. Sinto muita satisfação em cooperar com meu trabalho e pesquisa para a saúde das pessoas e do meio ambiente e, desejo compartilhar um pouco da minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Por isso, fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

# Iconográficos

Olá. Meu nome é **Manuela César de Arruda**. Sou a responsável pelo projeto gráfico de seu material. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:



**INTRODUÇÃO:**  
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;



**NOTA:**  
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;



**EXPLICANDO MELHOR:**  
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;



**SAIBA MAIS:**  
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;



**ACESSE:**  
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;



**ATIVIDADES:**  
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;



**DEFINIÇÃO:**  
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;



**IMPORTANTE:**  
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;



**VOCÊ SABIA?**  
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;



**REFLITA:**  
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;



**RESUMINDO:**  
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;



**TESTANDO:**  
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

# SUMÁRIO

## **Contexto histórico-social da “criação” da Vigilância em Saúde ..... 12**

Brasil Colônia e Brasil Império: Quando o país já praticava vigilância em saúde sem ter conhecimento .....12

Brasil República: Medicina higienista em ascensão e a reorganização dos serviços de saúde ..... 15

Dos anos 70 aos dias atuais .....17

## **A Secretaria de Vigilância em Saúde..... 19**

A criação da Secretaria de Vigilância em Saúde, sua organização e competências .....19

A Programação de Vigilância em Saúde.....25

O Financiamento da Vigilância em Saúde ..... 26

## **Política Nacional de Vigilância em Saúde .....29**

A instituição da Política Nacional de Vigilância em Saúde e seu objetivo .....29

## **Conceito de Vigilância em Saúde e os seus componentes ....31**

Conceito e características da Vigilância em Saúde..... 31

Componentes da Vigilância em Saúde .....33

# UNIDADE

# 01

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

# INTRODUÇÃO

Olá, qual a sua expectativa para esta disciplina? Você sabe qual a relevância da Vigilância em Saúde na vida das pessoas? Ela permeia diversas áreas da nossa vida, como o estabelecimento de condições higiênico-sanitárias relacionadas à manipulação de alimentos, fiscalização das indústrias de medicamentos, o consumo de água, o combate à Zika, à dengue e outras arboviroses, a notificação de doenças e epidemias, assistência e prevenção da saúde do trabalhador e muito mais. A Vigilância em Saúde no Brasil tem uma história totalmente conectada com os diversos contextos histórico-sociais e da saúde vividos em nosso país. No entanto, é uma área relativamente emergente, já que apenas nos últimos anos o olhar dos nossos governantes e da sociedade se abriram para o tamanho da importância da Vigilância em Saúde na promoção e prevenção da saúde pública. E aí, preparado para ampliar seus conhecimentos? Vamos juntos nessa!

# OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à Unidade 1 – Vigilância em Saúde. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

- Conhecer o contexto histórico-social que levou à “criação” da Vigilância em Saúde;
- Identificar a atuação da Vigilância em Saúde nas diferentes esferas governamentais;
- Conhecer a Política Nacional de Vigilância em Saúde;
- Compreender o conceito de Vigilância em Saúde e os seus componentes.

Vamos, então, rumo ao conhecimento. Bons estudos!

# Contexto histórico-social da “criação” da Vigilância em Saúde

## INTRODUÇÃO:



Ao término deste capítulo você será capaz de entender como se deu o surgimento da Vigilância em Saúde e como ela funciona. Compreender a situação da saúde em meio aos principais eventos ocorridos na história da sociedade brasileira que levaram à “criação” da Vigilância em Saúde. Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!

Para que possamos aprender juntos sobre as vigilâncias: sanitária, epidemiológica e ambiental é imprescindível que estudemos e discutamos sobre algo antes: a Vigilância em Saúde. Já que as demais vigilâncias são componentes (ou subsistemas) da Vigilância em Saúde.

## Brasil Colônia e Brasil Império: Quando o país já praticava vigilância em saúde sem ter conhecimento

A trajetória da Vigilância em Saúde no Brasil se emaranha com muitos detalhes históricos bem relevantes quanto ao contexto da saúde e, por isso, vale a pena conversarmos um pouco sobre ele.

Tente imaginar o cenário: o Brasil recém-descoberto pelos povos de outros continentes, alta taxa de imigração europeia, além de escravos trazidos da África (de onde a varíola era endêmica). Choques não apenas cultural, mas econômico e também sanitário.

Foi nesse contexto do Brasil Colonial e Imperial que surgiram as primeiras ações sobre as doenças transmissíveis em nosso país. O registro mais antigo de ações de prevenção e controle dessas doenças é referente à adoção de medidas para conter uma epidemia

de febre amarela no Porto de Recife, em Pernambuco, no final do século XVII. Para evitar a propagação da doença foram aterradas águas estagnadas, cemitérios foram criados e as ruas e casas foram limpas. Este "movimento" inaugurou uma nova prática em que medidas voltadas para o indivíduo, como o isolamento, foram aliadas às ações que tinham por objetivo destruir ou transformar tudo o que, no meio urbano, fosse considerado causa da doença. Porém, como o fator desencadeante dessas medidas era a própria endemia, assim que ela foi controlada, as medidas saneadoras foram desativadas, o que em pouco tempo acabava levando ao surgimento de outras doenças e epidemias.

---

#### SAIBA MAIS:



Você pode conhecer um pouco mais sobre as doenças desse período e os impactos na saúde dos índios e dos colonizadores através do livro "Doenças e curas: o Brasil nos primeiros séculos", de Cristina Gurgel. A autora descreve as doenças deste momento em que a história do Brasil começava a ser escrita. Fala também das práticas curativas e da visão dos nativos e a visão dos europeus que aportaram no país quanto à medicina. Nesse link você encontra uma reportagem sobre o livro realizada pelo Jornal da Unicamp: <https://bit.ly/2K5WiLE>.

---

Nesse tempo ainda não havia estruturação da saúde em nosso país. Enquanto surgia a medicina moderna no mundo, os índios nativos do Brasil associavam as doenças à castigos ou provações, que surgiam pela vontade de um ser sobrenatural, pela ação dos agentes climáticos ou por algum feitiço. E buscavam a cura em rituais junto ao pajé, curandeiro da tribo e no uso de plantas e ervas. Logo, foi com a presença dos colonizadores (e das doenças trazidas por eles) que surgiu a necessidade de adotar ações para o controle dessas doenças que dizimavam a população, a exemplo da varíola e da febre amarela.

Figura 1: Rituais dos índios junto ao pajé



Fonte: © Kuhnert, Wilhelm. (1865–1926) / Wikimedia Commons

Nesse momento, os serviços de saúde no Brasil eram muito precários, e estavam voltados essencialmente, para o controle das pestes, doenças que se disseminavam rapidamente e que apresentavam alta letalidade. Na época, a estratégia de controle baseava-se no afastamento ou no confinamento dos doentes, principalmente, nas Santas Casas de Misericórdia, no entanto essa estratégia tinha função mais assistencialista do que curativa.

Com a chegada da Coroa Portuguesa ao Brasil, em 1808, logo foi instituída uma ação chamada de Polícia Médica, que teve sua origem na Alemanha, no século XVIII. A concepção da Polícia Médica era muito interessante, pois tinha como fundamento a intervenção nas condições de vida e saúde da população, buscando dessa forma vigiar e controlar o aparecimento de epidemias.

Uma nova organização para o governo que buscava o controle das epidemias ia surgindo pouco a pouco, na medida em que cresciam as preocupações com a saúde da população e, principalmente, com a

saúde da Família Real, além da necessidade do saneamento dos portos como estratégia para o desenvolvimento de relações mercantis. Já que o Brasil a essa altura ganhava notoriedade e a abertura dos portos, intensificou o comércio exterior.

Em 1809, a palavra "vigilância" aparece em um decreto do Príncipe Regente ao criar o cargo de Provedor-mor da Saúde. Vamos ver o trecho inicial do decreto:

Tendo consideração ao muito que interessa o bem público e o particular dos meus fiéis vassallos na conservação da saúde pública; devendo haver todo o zelo, cuidado e **vigilância**, em que ela não perigue por contágio, fiscalizando-se o estado de saúde das equipagens das embarcações, que vêm de diversos Portos e, obrigando-se a dar fundeio em mais distâncias as que saírem de áreas suspeitas de peste, ou moléstias contagiosas e, a demorar-se por algum tempo os que nelas se transportarem; e em se afastarem do uso, e mercados comuns, os comestíveis, os gêneros corrompidos, ou iscados de princípios de podridão [...]. Coleção das Leis do Brasil de 1809, Parte 1. Decreto de 28 de junho de 1809. Cria o lugar de Provedor-mor da Saúde.

A partir desse Decreto, já podemos perceber os princípios da vigilância sendo introduzidos na saúde pública.

A primeira Regulamentação dos Serviços de Saúde dos Portos foi promulgada em 1889 e teve por objetivo evitar que epidemias originadas em outros países chegassem ao Brasil. Também trazia definições que visavam o estabelecimento de um intercâmbio seguro das mercadorias.

## **Brasil República: Medicina higienista em ascensão e a reorganização dos serviços de saúde**

Adentrando o século XX, muitos europeus emigraram para o Brasil e essas pessoas eram muitos susceptíveis a doenças tropicais. Aliando-se a isso a péssima situação sanitária do país, a economia brasileira começou a se enfraquecer. Muitos navios já se recusavam a vir ao país.

O Brasil nesse momento buscava se organizar como república, logo era necessário montar uma estrutura sanitária que pudesse responder a demanda das necessidades de saúde geradas nesse processo de desenvolvimento social e econômico. A fiscalização já não era mais suficiente, foi quando surgiu a necessidade de uma ação governamental mais resolutiva, com bases científicas.

Diante dessa situação, a medicina higienista e as estratégias de saneamento começaram a ser bastante atuantes nas regiões com epidemias. Foi quando o saneamento passou a fazer parte da pauta do planejamento de grandes cidades, como São Paulo, Santos e Rio de Janeiro, que foram as primeiras cidades a serem contempladas com programas de medidas para o saneamento urbano.

Note que a partir desse momento há um início de mudança de pensamento quanto ao combate contra as doenças, mesmo que motivado por interesses econômicos, o entendimento da prevenção começava a surgir.

No entanto, as estratégias de combate às doenças pestilenciais, como a cólera, a febre amarela, a varíola e a peste bubônica, bem como às doenças infecciosas e parasitárias, como tuberculose, febre tifoide e hanseníase ainda era o foco da atenção da gestão pública, já que essas doenças continuavam afetando a população com muita intensidade.

Foi quando se deu início a um processo de reorganização dos serviços de higiene, cujo Governo Federal era responsável pela coordenação das ações de prevenção e controle das doenças transmissíveis. As primeiras medidas resultantes desse processo foi a criação do Serviço de Profilaxia da Febre Amarela, em 1903, quando Oswaldo Cruz assumiu a Direção Geral de Saúde Pública e, a obrigatoriedade da vacina contra a varíola, que teve sua lei promulgada em 1904.

Figura 2: Revolta da Vacina



Fonte: Leonidas Freire (1882 - 1943) / Wikimedia Commons

Desde então, o Governo Federal passou a formular, coordenar e executar todas as ações de vigilância, prevenção e controle das doenças transmissíveis e estas ações passaram a ser organizadas como programas verticalizados.

## Dos anos 70 aos dias atuais

Já em 1969, após a criação do Centro de Investigações Epidemiológicas (CIE), quando os conceitos e as práticas da vigilância moderna passaram a vigorar, o primeiro sistema de notificação regular para o monitoramento epidemiológico de algumas doenças transmissíveis foi implementado. Esse monitoramento tinha origem nas unidades das Secretarias Estaduais de Saúde.

No início da década de 70, junto às doenças infectocontagiosas, que eram características das sociedades subdesenvolvidas, o Brasil também apresentava os efeitos negativos da industrialização, as doenças crônico-degenerativas. Doenças endêmicas das regiões rurais

passaram para o meio urbano, a malária voltou a ocorrer e houve um agravamento da desnutrição, tuberculose e hanseníase.

Nesse contexto, algumas mudanças relativas às práticas específicas dentro da Saúde Coletiva passam a gerar dissociação das suas modalidades de intervenção. Ou seja, aos poucos, as ações de controle de doenças transmissíveis foram se organizando em torno da vigilância epidemiológica e as demais práticas perdem a vinculação que existia nos períodos anteriores. À exemplo disso, temos o saneamento que passava para a responsabilidade de outro setor e o controle de bens de consumo, que agora se organizava de forma autônoma.

A dissociação se consolidou de fato a partir de 1975. Nesse ano, foi promulgada a Lei Nº 6.229 que organizava o Sistema Nacional de Saúde. Essa lei surgiu em meio à uma grave crise sanitária que ocorria no país, com uma epidemia de doença meningocócica, aumento da mortalidade infantil e números elevados de ocorrências de acidentes de trabalho. Daí foram criados o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SNVE) e o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS).

A Vigilância Epidemiológica então respondia pelo controle de doenças, particularmente das doenças transmissíveis e a Vigilância Sanitária ficou responsável pela fiscalização dos portos, aeroportos, fronteiras, medicamentos, alimentos, cosméticos e bens. Apesar de terem sido definidas inter-relações entre as duas vigilâncias, na prática elas passaram a se tornar cada vez mais independentes entre si.

Por volta dos anos 90, algumas secretarias estaduais e municipais de saúde instituíram novas unidades em sua estrutura organizacional para unificar administrativamente a vigilância epidemiológica e outras vigilâncias, como a sanitária e a de saúde do trabalhador. Essas novas unidades foram designadas como Vigilância à Saúde ou Vigilância da Saúde.

# A Secretaria de Vigilância em Saúde



## INTRODUÇÃO:

Chegou a hora de compreender como a Vigilância em Saúde está presente dentro do Ministério da Saúde e ver sua atuação em cada esfera governamental. Vamos lá?!

## A criação da Secretaria de Vigilância em Saúde, sua organização e competências

Em 2003, foi criada a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS), por meio do Decreto Nº 4.726. Suas atividades abrangiam:

os programas nacionais de combate à dengue, à malária e a outras doenças transmitidas por vetores, o Programa Nacional de Imunização, a prevenção e controle de doenças imuno-preveníveis, a vigilância das doenças de veiculação hídrica e alimentar, o controle de zoonoses e a vigilância de doenças emergentes (BRASIL, 2005).

A Portaria Nº 1.172, de 15 de junho de 2004, do Ministério da Saúde, aprimora o processo de descentralização das ações da vigilância em saúde. A Portaria regulamentou a Norma Operacional Básica do SUS 01/96 definindo o que compete a cada esfera governamental (União, Estados, Municípios e Distrito Federal) quanto à Vigilância em Saúde.

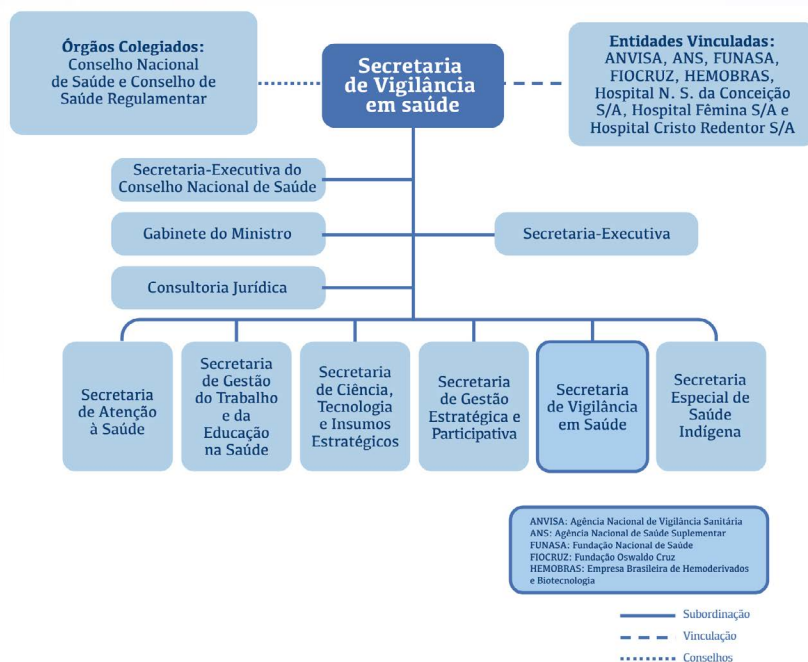
Em 2007 mais uma atividade foi atribuída à vigilância em saúde. Por meio da Portaria GM/MS Nº 1.956/07 a gestão federal da saúde do trabalhador é transferida da Secretaria de Atenção à Saúde para a SVS.

No entanto os atos normativos são atualizados mais uma vez na busca de consolidar o processo de descentralização das ações de vigilância em saúde. Assim, o papel gestor dos estados e municípios é fortalecido e as ações de Vigilância em Saúde tem seu escopo

ampliado por meio da Portaria GM/MS nº 1.378, de 2013 (atual Portaria de Consolidação MS Nº 4/ 2017, Anexo III).

Veja como se posicionou a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) dentro de Ministério da Saúde, de acordo com a Portaria Nº 3.965/ 2010, que aprovou os regimentos internos dos órgãos pertencentes ao MS:

Figura 3: Estrutura organizacional do Ministério da Saúde com destaque da Secretaria de Vigilância em Saúde



Fonte: Regimentos Internos e Organogramas Básicos do Ministério da Saúde. 2010. Pág. 7. Disponível em <https://bit.ly/2Oo88wE>

Atualmente, a SVS é responsável pela coordenação do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde (SNVS). Esse sistema é composto por dois subsistemas: o Subsistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SNVE) e o Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental (SINVSA).

O SNVE foi instituído pelo Decreto 78.321/1976, após a realização da V Conferência Nacional de Saúde que demonstrou a importância de um sistema para o auxílio das ações da vigilância epidemiológica. No Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica são gerenciadas informações, dados e investigações que serão utilizadas no planejamento e organização dos programas de controle de doenças e agravos à saúde e na avaliação das ações dos mesmos. O controle de doenças transmissíveis, na época, foi o motivador principal da criação do SNVE que demonstrou grande importância para a vigilância epidemiológica dentro do Ministério da Saúde. Contudo o SNVE não se resume a isso, pois também visa o controle de doenças não transmissíveis.

O SINVSA é uma redefinição do antigo Sistema Nacional de Vigilância Ambiental em Saúde – SINVAS. A alteração de sistema para subsistema indica agora a integração do SINVSA ao SNVS, enquanto a mudança na denominação da área de "vigilância ambiental em saúde" para "vigilância em saúde ambiental" teve por objetivo trazer o foco para a vigilância em saúde, mas não deixando de reconhecer o ambiente como componente do processo saúde-doença.

Os programas de prevenção e controle de doenças de importância na saúde pública também fazem parte do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, como por exemplo o Programa Nacional de Imunizações.

A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, instituída em 2012 através da Portaria MS Nº 1.823, também integra o SNVS. Sem dúvida, essa Política tão recente é um marco para a vigilância em saúde do trabalhador, pois ela chega como um instrumento de definição da atuação do SUS no campo da Saúde do Trabalhador num momento de elevadas taxas de morbimortalidade dos trabalhadores. A definição da atuação do SUS na saúde do trabalhador visa justamente, com ênfase na vigilância, a promoção e a proteção, bem como a atenção integral à saúde desse grupo de pessoas.

Ainda integram a Secretaria de Vigilância em Saúde: o Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública (SISLAB) e os sistemas de informação de vigilância em saúde. O SISLAB é formado por quatro redes interligadas de laboratórios espalhados por todo o país que visam subsidiar as ações da vigilância em saúde. Os laboratórios pertencentes

as Redes realizam diagnósticos, vigilância e monitoramento de agravos, doenças e/ou programas relacionados à vigilância epidemiológica (Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Epidemiológica), à vigilância ambiental (Rede Nacional de Laboratório de Vigilância em Saúde Ambiental), à vigilância sanitária (Rede Nacional de Vigilância Sanitária) e à assistência médica (Rede Nacional de Laboratórios de Assistência Médica de Alta Complexidade).

Um sistema de gerenciamento de exames e ensaios relativos a amostras de origem humana (biologia médica), animal e ambiental foi desenvolvido pela Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde Pública (CGLAB) junto com o DATASUS, que é o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. O Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL) é alimentado pelos Laboratórios de Saúde Pública, pelas Gerências Regionais de Saúde e Hospitais que realizam as solicitações de exames e ensaios, e diversas instituições parceiras, como a Fiocruz e o Instituto Evandro Chagas. O GAL além de agilizar o compartilhamento dos resultados das análises laboratoriais já que se trata de um sistema on-line, tem se tornado um banco de dados com diversas informações das várias áreas da Vigilância em Saúde e, portanto, podendo ser um grande aliado na análise de situação de saúde das diferentes regiões do país.

Figura 4: Página inicial do Portal de acesso do Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial - GAL

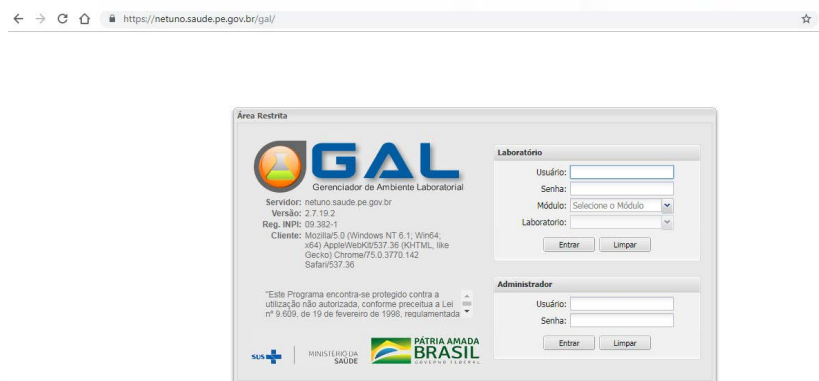


Imagem pública extraída do portal de acesso ao Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL) do Estado de Pernambuco

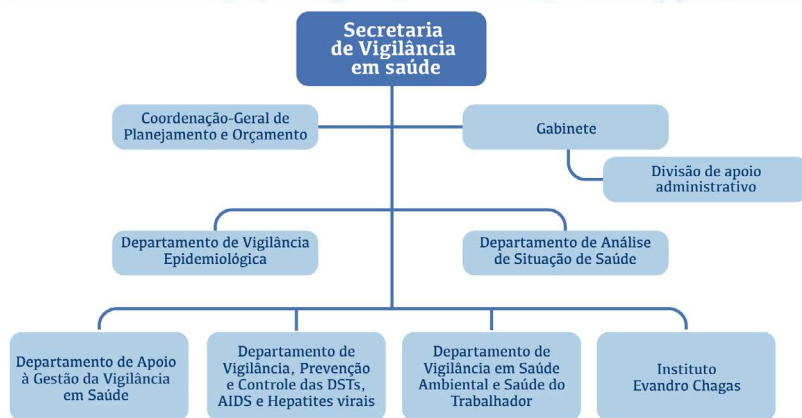
A criação da Secretaria de Vigilância em Saúde teve um papel relevante na integração das vigilâncias nos diferentes níveis governamentais. Você pode notar que a SVS fortaleceu e ampliou as ações da vigilância epidemiológica. Os programas nacionais de combate à tuberculose, hanseníase, DST e AIDS passaram a fazer parte da Secretaria. As ações de prevenção e controle das doenças se tornaram partes constitutivas da mesma estrutura, o que possibilitou uma abordagem mais integrada e eficaz entre elas. Além de configurar o mesmo patamar de importância para todas as vigilâncias coordenadas por ela.

A SVS também é responsável pela elaboração e divulgação de dados e análise de situação da saúde, pelo monitoramento sanitário do país, pela coordenação da execução das atividades relacionadas à disseminação do emprego da metodologia epidemiológica no âmbito do SUS e à prevenção e ao controle de doenças e agravos. As atividades técnicas desenvolvidas pelo Instituto Evandro Chagas também são coordenadas e supervisionadas pela SVS.

Ainda compete à Secretaria de Vigilância em Saúde, a cooperação e a prestação de assessoria técnica aos Estados, Municípios e Distrito Federal, a promoção do intercâmbio científico na área de Vigilância em Saúde, e o incentivo e fomento de estudos e pesquisas que possam colaborar com o aperfeiçoamento das ações de VS.

Essas e outras competências da SVS estão distribuídas e organizadas por suas coordenações e departamentos. Observe a estrutura atual da Secretaria de Vigilância em Saúde:

Figura 5: Estrutura organizacional da Secretaria de Vigilância em Saúde



Regimentos Internos e Organogramas Básicos do Ministério da Saúde. 2010. Pág. 297. Disponível em <https://bit.ly/2Oo88wE>

As Secretarias Estaduais (SEVS) e Municipais de Saúde (SMVS) se tornaram parceiras da Secretaria de Vigilância em Saúde, que também conta com a cooperação de instituições de pesquisa e ensino, nacionais e internacionais. As SEVS e as SMVS são responsáveis pela coordenação estadual e municipal, respectivamente, dos Sistemas Nacionais de Vigilância em Saúde e de Vigilância Sanitária, no âmbito de seus limites territoriais e, de acordo com as políticas, diretrizes e prioridades estabelecidas.



SAIBA MAIS:

Deseja saber mais sobre as competências e ações da Vigilância em Saúde? Acesse o link: <https://bit.ly/3oW8EU7>.

## TESTANDO:



Que tal identificar as competências dos municípios referentes à Vigilância em Saúde descritas no Anexo III da Portaria de Consolidação MS Nº 4/ 2017 e verificar se o seu município está cumprindo com o que a Portaria diz?

## A Programação de Vigilância em Saúde

Para assegurar a concretização das prioridades da SNVS e do alcance das metas do Pacto em Saúde, em 2008, através da Portaria MS Nº 64, o Ministro da Saúde estabeleceu a Programação de Vigilância em Saúde (PAVS). O PAVS é um instrumento de planejamento que auxilia as esferas governamentais a definirem as prioridades e ações da VS a serem operacionalizadas em determinado ano.

As ações e parâmetros que deverão nortear a PAVS devem ser estabelecidos anualmente com a concordância do Ministério da Saúde, do CONASS e do CONASEMS. Como esse acordo é realizado entre as três esferas, federal, estadual e municipal, logo as ações e parâmetros que norteiam a PAVS respeitam o determinado pela SVS, mas possui flexibilidade para atender as demandas de cada estado e/ou município.

O monitoramento da PAVS é realizado pela SVS junto às Secretarias Estaduais de Saúde, que por sua vez tem a responsabilidade de realizar o monitoramento junto às SMS's subordinadas. E anualmente os gestores de cada uma das esferas (federal, estadual e municipal) deverão realizar a avaliação das ações executadas da PAVS, incluindo esta avaliação em seu respectivo relatório de gestão.

---

### VOCÊ SABIA?



CONASS é a sigla do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. O CONASS visa o fortalecimento das secretarias estaduais de saúde, bem como torná-las mais atuantes e representativas politicamente. CONASEMS é a sigla do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. O CONASEMS representa as secretarias municipais de saúde distribuídas por todo o país, buscando valorizar as especificidades e demandas de cada município na área da saúde.

---

## O Financiamento da Vigilância em Saúde

O financiamento da Vigilância em Saúde é regulamentado pela Portaria de Consolidação Nº 4/ 2017 Anexo III (origem na Portaria MS Nº 1.378/ 2013). Os recursos federais destinados às ações da VS estão organizados no Bloco Financeiro de Vigilância em Saúde (BFVS). Esse bloco é formado por dois componentes, o da vigilância em saúde e o da vigilância sanitária, no entanto os recursos pertencentes a um componente podem ser utilizados pelo outro a depender da demanda. Esses recursos são transferidos regularmente do Fundo Nacional de Saúde para os fundos estaduais e municipais.

O componente de vigilância em saúde é constituído por um piso fixo e um piso variável, e também pela Assistência Financeira aos Agentes de Combate às Endemias. O Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) é destinado às ações da vigilância em saúde como um todo (por exemplo, vigilância de doenças transmissíveis, de riscos ambientais em saúde, etc.), seja para custeio de ações ou investimentos. E seus recursos são ajustados com base na população estimada pelo IBGE, todos os anos, e um valor "per capita" é estabelecido conforme a situação epidemiológica das unidades federadas e do grau de dificuldade operacional (seja recursos humanos, equipamentos, estrutura física, etc.) para que as ações da VS possam ser executadas. As unidades federadas

foram agrupadas em três extratos de acordo com a legislação para o financiamento das ações de Vigilância em Saúde:

Tabela 1: Estratificação das unidades federadas para efeito do Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) de acordo com a legislação vigente

| ESTRATO | UNIDADE FEDERATIVA                                                                                                                                                                       |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I       | Amazonas, Amapá, Pará, Acre, Rondônia, Roraima, Mato Grosso (1), Tocantins e Municípios pertencentes à Amazônia Legal dos Estados do Maranhão (1)                                        |
| II      | Mato Grosso (2), Rio Grande do Norte, Alagoas, Ceará, Goiás, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Maranhão (2), Paraíba, Sergipe, Rio de Janeiro, Pernambuco e Piauí |
| III     | Distrito Federal, Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina                                                                                                                  |

Fonte: O Autor

Essa estratificação teve por objetivo respeitar as diferenças regionais e promover equidade na distribuição dos recursos entre as unidades federadas.

O Piso Variável de Vigilância em Saúde (PVVS) é composto por incentivos financeiros específicos. Esses incentivos são recebidos através da adesão dos entes federados e dividem-se em três de acordo com a Portaria MS Nº 1.378/ 2013:

- I - incentivo para implantação e manutenção de ações e serviços públicos estratégicos de vigilância em saúde;
- II - incentivo às ações de vigilância, prevenção e controle das DST/AIDS e hepatites virais; e
- III - Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde.

Existe também uma reserva estratégica federal à disposição da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde de 5% dos recursos anuais do componente de vigilância em saúde que poderá ser utilizado em emergências epidemiológicas.

Os recursos do Bloco Financeiro de Vigilância em Saúde devem ser aplicados exclusivamente em ações de vigilância em saúde. Dessa forma, a recomendação do Ministério da Saúde é de que um plano de aplicação dos recursos do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde seja elaborado juntamente com o Plano Estadual/ Municipal, para que contemple todas as demandas de uso desses recursos, como treinamentos, consultorias, equipamentos, material de consumo, entre outros.

E é através do Relatório Anual de Gestão que a aplicação dos recursos do BFVS deve ser comprovada, aprovado pelo respectivo conselho de saúde. Já a manutenção do repasse desses recursos está condicionada à alimentação regular do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), do Sistema de Informação de Nascidos Vivos (SINASC) e do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). Portanto, caso sejam constatados dois meses consecutivos sem a alimentação de um desses sistemas, os recursos relacionados aos componentes da vigilância em saúde são bloqueados, segundo os parâmetros estabelecidos em lei.

Por isso, os agravos de notificação compulsória ou notificação negativa devem ser notificados pelas secretarias municipais de saúde semanalmente, e tanto as municipais quanto as secretarias estaduais de saúde também devem transferir os dados referentes às declarações de óbito.

O Ministério da Saúde publica atos normativos específicos com a relação das secretarias que têm seus recursos bloqueados. O Fundo Nacional de Saúde é que realiza o desbloqueio dos recursos, e isso apenas no mês seguinte ao serem enviados pela secretaria pendente os dados referentes aos meses que provocaram o bloqueio.

# Política Nacional de Vigilância em Saúde

## INTRODUÇÃO:



Quando terminar a leitura deste item você será capaz de entender como funciona a Política Nacional de Vigilância em Saúde, seus princípios e diretrizes. Vamos lá! Ainda há muito que aprender!

## A instituição da Política Nacional de Vigilância em Saúde e seu objetivo

Em 12 de julho de 2018, o Conselho Nacional de Saúde (CNS) instituiu a Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS), por meio da Resolução N° 588/2018.

A Política Nacional de Vigilância em Saúde tem como objetivo definir os princípios, as diretrizes e as estratégias para o desenvolvimento da vigilância em saúde na atuação do SUS pelas três esferas do governo.

## SAIBA MAIS:



Para saber mais sobre do que se trata o Conselho Nacional de Saúde e suas atribuições, leia o texto disponível em: <https://bit.ly/1OXqqll>.

A PNVS compreende a articulação dos saberes, processos e práticas relacionados à vigilância epidemiológica, vigilância em saúde ambiental, vigilância em saúde do trabalhador e vigilância sanitária e alinha-se com o conjunto de políticas de saúde no âmbito do SUS, considerando a transversalidade das ações de vigilância em saúde sobre a determinação do processo saúde-doença (Resolução N° 588/2018, Art. 3°).

A PNVS tem como princípios, semelhantemente ao SUS: a integralidade, a equidade, a universalidade, a descentralização político-administrativa, o conhecimento do território, a inserção da vigilância em saúde no processo de regionalização das ações e serviços de saúde, a participação da comunidade, a cooperação e articulação intra e intersectorial para ampliar a atuação sobre determinantes e condicionantes da saúde, a garantia do direito das pessoas e da sociedade às informações geradas pela Vigilância em Saúde, e a organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

---

#### VOCE SABIA?



A 1ª Conferência Nacional em Vigilância em Saúde foi realizada em 2018, entre os dias 27 de fevereiro e 02 de março, em Brasília. A Conferência, cujo tema central foi "Vigilância em Saúde: Direito, Conquista e Defesa de um SUS Público de Qualidade", teve papel fundamental na discussão das diretrizes para a construção da Política Nacional de Vigilância em Saúde.

---

#### ACESSE:



Para saber mais sobre a 1ª CNVS e saber o que foi discutido na conferência e as perspectivas pós-evento. Assista ao vídeo I Conferência Nacional de Vigilância em Saúde – Et. Nac. exibido em 27/03/2018 pelo Canal Saúde da Fiocruz. Disponível em: <https://bit.ly/2Yrcel5>.

---

A PNVS foi fruto da luta de muitos profissionais da saúde que almejavam por um documento que nortearse o planejamento das ações de vigilância em saúde. E é assim que a PNVS se apresenta: com clareza quanto aos seus princípios, suas diretrizes e suas estratégias,

bem como quanto às competências e responsabilidades de cada esfera governamental dentro da Política.

Além disso, a PNVS trata também de aspectos referentes ao financiamento das ações da vigilância em saúde, prevendo a garantia de que esse financiamento ocorra de forma tripartite, com recursos e tecnologia suficientes para que cada nível de gestão possa cumprir plenamente seu papel institucional quanto à VS.

Outros avanços abordados na Política Nacional de Vigilância em Saúde dizem respeito à promoção do controle social e também aos treinamentos para formação e capacitação em vigilância para profissionais do SUS. A Política também visa estimular o desenvolvimento das áreas de educação, mobilização social e comunicação em prol da vigilância em saúde.

## Conceito de Vigilância em Saúde e os seus componentes

---

### INTRODUÇÃO:



Chegamos ao último item dessa Unidade! Aqui você vai conhecer o conceito atual de Vigilância em Saúde e os seus componentes definidos em lei. Alguns componentes nós iremos trabalhar melhor nas futuras unidades. Aproveite!

---

## Conceito e características da Vigilância em Saúde

Por definição em lei, a Vigilância em Saúde trata-se do:

processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise de dados e disseminação de informações sobre eventos relacionados à saúde, objetivando o planejamento e a implementação de medidas de saúde pública, incluindo

ainda a regulação, intervenção e atuação em condicionantes e determinantes da saúde, com a finalidade de proteção e promoção da saúde da população, prevenção e controle de riscos, agravos e doenças.

Alexander Langmuir, epidemiologista norte-americano, trouxe um dos mais reconhecidos conceitos acerca da vigilância em saúde, que seria:

a observação contínua da distribuição e tendências da incidência de doenças mediante a coleta sistemática, consolidação e avaliação de informes de morbidade e mortalidade, assim como de outros dados relevantes, e a regular disseminação dessas informações a todos os que necessitam conhecê-la. (BRASIL, 2005)

Logo, o objetivo da Vigilância em Saúde é, justamente, através da análise permanente da situação de saúde do país, através do "retrato" das demandas loco-regionais, poder organizar e executar ações pertinentes ao controle de riscos, danos e determinantes da saúde, fazendo uso tanto de abordagens individuais quanto coletivas.

Por isso, não é difícil identificar as características da Vigilância em Saúde:

- 1) O caráter de atividade contínua, permanente e sistemática. Isso diferencia a VS dos estudos e levantamentos realizados de forma ocasional;
- 2) o foco dirigido para determinados resultados específicos;
- 3) a utilização de dados diretamente relacionados com a prática da saúde pública, ainda que outras informações possam subsidiar a análise da situação de determinadas doenças e seus fatores de risco;
- 4) o sentido utilitário da atividade, que tem por finalidade estabelecer o controle de doenças e não apenas a ampliação do conhecimento sobre elas. (BRASIL. CONASS, 2007. Vigilância em Saúde).

Então, você pode notar que a observação contínua, a coleta sistemática, a disseminação das informações e o sentido utilitário de controle são características inerentes à Vigilância em Saúde e que são

essas características que a diferenciam das demais práticas de saúde pública.

O cuidado integral à saúde das pessoas também é um aspecto fundamental da vigilância em saúde observado principalmente através da promoção da saúde.

## Componentes da Vigilância em Saúde

Como componentes da Vigilância em Saúde, definidos em lei, temos a Análise de Situação de Saúde, a Vigilância em Saúde Ambiental, a Vigilância em Saúde do Trabalhador, a Vigilância Epidemiológica e a Vigilância Sanitária.

Figura 6: Componentes da Vigilância em Saúde



Fonte: Editorial Telesapiens

De forma sucinta, a **Análise de Situação de Saúde** é a área da vigilância em saúde responsável por monitorar continuamente a situação de saúde do território, através de estudos e análises que mostrem os principais indicadores de saúde do país. Através da análise dessas informações pode se gerar um quadro da situação de saúde e

assim planejamentos mais eficientes são elaborados a fim de priorizar as questões mais relevantes de um determinado território.

A **vigilância epidemiológica** busca coletar dados e investigar as principais doenças de notificação compulsória e epidemias. Isso para promover a prevenção e o controle dessas doenças e agravos específicos, através de programas, ações educativas, campanhas de vacinação, etc.

Enquanto isso, a **vigilância em saúde ambiental** busca analisar às interferências dos ambientes físico, psicológico e social na saúde, diferentemente do que se possa imaginar, o ambiente relativo à vigilância em saúde ambiental, não diz respeito apenas ao meio ambiente, no sentido ecológico, mas também ao ambiente onde as populações estão inseridas. Logo diz respeito à qualidade do ar, da água, das condições do meio onde são desenvolvidas as atividades cotidianas do indivíduo e muito mais.

Por isso também a **vigilância de saúde do trabalhador** está bastante vinculada à vigilância de saúde ambiental, em virtude, por exemplo, da exposição de trabalhadores à agrotóxicos, que em caso de uso inadequado se tornam poluentes ambientais e nocivos à saúde humana, principalmente dos trabalhadores que são os mais expostos a este contaminante em específico. A vigilância de saúde do trabalhador visa a prevenção e promoção da saúde do trabalhador e da trabalhadora, e também a assistência e vigilância às doenças e aos agravos à saúde relacionados ao trabalho.

Já a **vigilância sanitária** abrange em suas ações o controle de bens, produtos e serviços que possam oferecer riscos à saúde da população. Esses produtos e serviços dizem respeito à quase tudo do nosso dia a dia: água mineral, alimentos, medicamentos, cosméticos, etc. Mas, também a vigilância sanitária é responsável por fiscalizar os serviços de interesse da saúde e inspecionar os processos de produção de bens, produtos ou insumos de forma a prevenir os riscos ao trabalhador, ao consumidor e ao meio ambiente.

Observe como "as vigilâncias" e a análise de situação de saúde se integram e precisam caminhar alinhadas para alcançar seus respectivos objetivos específicos e o propósito da Vigilância em Saúde.



#### SAIBA MAIS:

Para saber mais sobre as definições dos componentes da Vigilância em Saúde, leia a BRASIL. Resolução N° 588/2018, disponível em: <https://bit.ly/2YmHK6g>.

Sem dúvidas, a implantação da Vigilância em Saúde é um dos grandes desafios enfrentados pelo país na atualidade e, envolve mudanças tanto na gestão e organização do sistema do SUS, como na organização das práticas dos espaços onde interagem os profissionais de saúde e a população. O desenvolvimento das práticas de Vigilância em Saúde implica na mudança de concepção dos profissionais e trabalhadores de saúde, já que exige um esforço de redefinição do modo de pensar e de agir com relação à saúde e sua proteção e promoção no plano individual e coletivo.

# BIBLIOGRAFIA

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria de Consolidação Nº 4, de 28 de setembro de 2017. Consolidação das normas sobre os sistemas e os subsistemas do Sistema Único de Saúde. Brasília, DF. Acesso em 04 de Jun de 2019, disponível em [http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0004\\_03\\_10\\_2017.html](http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0004_03_10_2017.html)

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços. Guia de Vigilância em Saúde: volume único. 3ª. ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2019. 740 p.

BRASIL. Ministério da Saúde. Site do Conselho Nacional de Saúde. Apresentação. Acesso em 01 de Jul de 2019, disponível em <http://conselho.saude.gov.br/apresentacao/apresentacao.htm>

FRANCO NETTO, G., VILLARDI, J., MACHADO, J., SOUZA, M., BRITO, I., SANTORUM, J., OCKÉ-REIS, C., FENNER, A. Vigilância em Saúde brasileira: reflexões e contribuição ao debate da 1ª Conferência Nacional de Vigilância em Saúde. *Ciência & Saúde Coletiva*, 22 (10): 3137-3148, 2017.